

× 中心型早期肺癌は病巣の長径が 2 cm 以下で、内視鏡的に可視できる気管から亜区域支まで限局するものである。特に 1 cm 以下では光線力学的療法 (Photodynamic Therapy: PDT) が推奨される。

× 中心型早期肺癌は組織学的に扁平上皮癌であることが基準に含まれる。

× PD-L1 TPS 50% 以上の場合はペムブロリズマブ単剤、ニボルマブ+イピリムマブ併用、もしくはプラチナ製剤併用療法± PD-1/PD-L1 阻害薬が一次治療で適応となる。

○ ペムブロリズマブの一次治療は PD-L1 1% 以上で適応がある。

○ ニボルマブ+プラチナダブレットのレジメンは PD-L1 陰性例での適応となるが、他のレジメンは PD-L1 発現に関係なく使用可能である。

○ ニボルマブ+イピリムマブ併用療法は PD-L1 陰性でも適応がある。

× PS 良好例でのみ適応があり、PS2 以上では推奨されない。

× 他の免疫チェックポイント阻害薬と同様に、肺障害、胃腸傷害、内分泌傷害、皮疹などの免疫関連有害事象がみられる。

○

× 出血リスクがあるため、ベバシズマブは扁平上皮癌への投与は行わない。その他空洞病変、大血管への浸潤、出血の既往もベバシズマブ使用時における出血のリスクである。

○

× 浸潤性粘液腺癌では化学療法の効果が悪く、予後不良である。

11

